

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO PROTOCOLO

A ventilação mecânica (VM) é uma medida de suporte de vida fundamental na UTI. Entretanto, cada dia adicional de VM associa-se a aumento exponencial de riscos: **pneumonia associada ao ventilador (PAV)**, fraqueza muscular adquirida, delirium, barotrauma e aumento de mortalidade. Da mesma forma, sedação e analgesia inadequadas — tanto por excesso quanto por déficit — comprometem desfechos clínicos e humanização do cuidado.

Este protocolo baseia-se nas diretrizes da **SCCM (2018 PAD-ICU Guidelines)**, **ARDS Network**, **AMIB** e evidências de ensaios clínicos randomizados recentes, adaptado para a realidade dos hospitais de Sobral-CE.

■ Objetivos deste Protocolo:

- ✓ Padronizar a avaliação diária de sedação e analgesia (escala RASS e BPS/NRS)
- ✓ Garantir a realização diária do Spontaneous Awakening Trial (SAT) e Spontaneous Breathing Trial (SBT)
- ✓ Orientar a titulação de sedoanalgesia: analgesia-first, sedação mínima eficaz
- ✓ Definir critérios claros de prontidão, execução e sucesso do desmame ventilatório
- ✓ Reduzir dias de VM, PAV, delirium e tempo de internação em UTI

2. BUNDLE ABCDEF — O PILAR DA HUMANIZAÇÃO NA VM

Componente	Ação	Responsável
A – Assess & Manage Pain	Avaliar dor com BPS ou NRS; tratar analgesia ANTES de sedação	Medico / Enfermagem
B – SAT + SBT	Interromper sedação diariamente (SAT) + teste de respiração espontânea (SBT)	Medico / Fisioterapia
C – Escolha de Sedacao	Preferir agentes com menor delirium (dex, propofol); RASS alvo -1 a -2	Medico
D – Delirium: Monitorar	CAM-ICU a cada 8-12h; reduzir fatores precipitantes	Enfermagem / Medico
E – Exercicio Precoce	Mobilizacao precoce; fisioterapia motora a partir do D1	Fisioterapia
F – Familia	Incluir familia nos cuidados; orientacao sobre prognostico	Toda a equipe

■■ EVIDENCIA: A implementação do bundle ABCDEF reduz mortalidade em 68%, delirium em 28% e dias de VM em 3,3 dias (Ely et al., Lancet Resp Med 2019). A equipe multidisciplinar e MANDATORIA.

3. ESCALAS DE MONITORIZAÇÃO — RASS, BPS, NRS, CAM-ICU

3.1 RASS — Richmond Agitation-Sedation Scale

Escore	Nível	Descrição
+4	Combativo	Violento, risco imediato para a equipe
+3	Muito agitado	Puxa dispositivos, agressivo
+2	Agitado	Movimentos frequentes, dessincronia
+1	Inquieto	Ansioso, movimentos nao agressivos
0	Alerta e calmo	IDEAL — paciente no desmame

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

Escore	Nível	Descrição
-1	Sonolento	Abre olhos ao chamado (> 10s)
-2	Sedacao leve	Abre olhos brevemente (< 10s)
-3	Sedacao moderada	Movimento ao estímulo vocal; sem abertura ocular
-4	Sedacao profunda	Sem resposta vocal; responde a estímulo físico
-5	Não responsivo	Sem resposta a voz nem a estímulo físico

■ Alvo RASS: **-1 a 0** na maioria dos pacientes. **-2 a -3** somente em: SARA grave, hipertensão intracraniana, status epilepticus, pós-op imediato.

3.2 BPS — Behavioral Pain Scale (paciente SEM comunicação verbal)

Item	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos
Expressão facial	Relaxada	Parcialm. tensa	Muito tensa	Careteando
Movim. MMSS	Sem mov.	Parcialm. fletidos	Fletidos + dedos	Retraídos
Adaptação VM	Tolerando	Tossindo mas tolerando	Lutando contra VM	VM não controlada

Escore BPS: 3 (sem dor) a 12 (dor máxima). **Alvo: BPS ≤ 5.** Tratar com analgesia se BPS ≥ 6.

3.3 NRS — Numeric Rating Scale (paciente COM comunicação verbal)

Escala de 0 a 10. **0** = sem dor. **10** = pior dor imaginável. **Alvo: NRS ≤ 3.** Analgesia de resgate se NRS ≥ 4.

3.4 CAM-ICU — Confusion Assessment Method for ICU

Característica	Pergunta	Positivo se...
1. Início agudo ou flutuação	Ha mudança aguda no estado mental? Ou fluctua?	SIM a qualquer um
2. Inatenção	Teste das letras (SAVEAHAART) ou figuras	Erros > 2
3. Pensamento desorganizado	4 perguntas Sim/Não + comando simples	Erros ≥ 2
4. Nível consciência alt.	RASS diferente de zero	RASS ≠ 0

CAM-ICU POSITIVO = Características 1 + 2 + (3 ou 4). Aplicar 2x/dia. Registrar em prontuário.

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

4. PROTOCOLO DE SEDOANALGESIA — ABORDAGEM ANALGESIA-FIRST

4.1 Princípio Fundamental: Analgesia antes de Sedação

■ REGRA DE OURO: Toda dor não tratada causa agitação. Antes de aumentar sedação, SEMPRE avaliar e tratar dor. O manejo inadequado da dor é a principal causa de agitação na UTI.

4.2 Drogas Analgésicas — Escolha e Titulação

Fármaco	Dose	Via	Indicação / Observações
Fentanil	25-50 mcg bolus; infusão 25-200 mcg/h	EV	1ª linha VM; titulação rápida; cuidado SF acumulação
Morfina	2-5 mg bolus; infusão 2-10 mg/h	EV	Alternativa; evitar em IR (metabólito ativo 6-GL)
Remifentanil	0,05-0,2 mcg/kg/min	EV infusão	Desmame rápido; sem acúmulo; custo alto
Metadona	5-20 mg 8/8h	EV/VO	Rotação opioide; prolonga QT; facilita desmame
Dipirona	1-2g 6/6h (adjuvante)	EV	Múltiplos/dia; adjuvante; reduz dose opioide
Cetamina	0,1-0,5 mg/kg/h	EV infusão	SARA, broncoespasmo; adjuvante analgosedação
Paracetamol	1g 6/6h	EV/VO/SNG	Adjuvante multimodal; hepatotóxico > 4g/dia

4.3 Drogas Sedativas — Escolha e Titulação

Fármaco	Dose	Vantagens	Desvantagens / Cuidados
Propofol	5-50 mcg/kg/min	Curta ação; fácil titulação; desmame rápido	Depressão resp; PRIS > 48h dose alta; hipertrigliceridemia
Midazolam	0,02-0,1 mg/kg/h	Barato; amnésia; anticonvulsivante	Acúmulo; prolongamento VM; delírio; EVITAR > 48-72h
Dexmedetomidina	0,2-1,4 mcg/kg/h	Sem depressão resp; extubação com facilidade	Depressão resp; hipotensão; custo; não adequado aprofundado
Cetamina (sed.)	0,5-2 mg/kg/h	Preserva drive resp; broncodilatador; hemodinamicamente estável	Aumento da secreção; dissociativo
Lorazepam	1-4 mg/h	Alternativa BZD longa ação	Acúmulo; delírio; evitar como 1ª linha

■■ SÍNDROME DE INFUSÃO DO PROPOFOL (PRIS): Suspeitar se acidose metabólica, rabdomiólise, hipercalemia, ICC, lipemia com propofol > 4 mg/kg/h por > 48h. Dose de segurança: < 4 mg/kg/h. Monitorar CK, TG, lactato.

4.4 Algoritmo de Titulação Diária (Fluxo Analgesia-First)

PASSO	AÇÃO	DESFECHO
1º	Avaliar dor: BPS ou NRS a cada 4-6h	BPS ≤ 5 / NRS ≤ 3?
2º	Se dor: bolus analgésico EV + ajustar infusão	Reavalie em 30 min
3º	Avaliar RASS após analgesia adequada	RASS alvo atingido?
4º	Se RASS > alvo (agitação): investigar causas (dor, globo vesical, tubo, etc.)	Tratar causa + sedativo se necessário
5º	Se RASS < alvo (hipersedação): reduzir 25-50% dose sedativo	Titular até alvo

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

PASSO	AÇÃO	DESFECHO
6°	Considerar dexmedetomidina em pacientes com delirium + agitação	CAM-ICU a cada turno
7°	Realizar SAT diário (ver seção 5)	Avaliar prontidão para desmame

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

5. DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA — PROTOCOLO SAT + SBT

5.1 Critérios de Prontidão para o Desmame (Screening Diário — TODA manhã)

Domínio	Critério	Meta
Causa da VM	Motivo de intubação resolvido ou em resolução	SIM
Oxigenação	SpO ₂ ≥ 92% com FiO ₂ ≤ 0,4 e PEEP ≤ 8 cmH ₂ O (ou PaO ₂ /FiO ₂ > 350)	SIM
Hemodinâmica	Sem vasopressores (ou dose baixa estável: NE ≤ 0,1 mcg/kg/min)	SIM
Neurológico	RASS ≥ -2; GCS ≥ 10; sem sedação contínua ou dose mínima	SIM
Respiratório	FR espontânea < 35 ipm; VT espontâneo > 5 ml/kg; P _l max > -20 cmH ₂ O	SIM
Tosse / Secreção	Tosse eficaz ou capaz de limpar vias aéreas; secreção manejável	SIM
Temperatura	Afebril (T < 38,5°C) ou febre sendo tratada	SIM
Eletrólitos	K ⁺ , Mg ²⁺ , P ₃ - corrigidos	SIM

■ Todos os critérios presentes → prosseguir para SAT. Qualquer critério ausente → reavaliar em 24h.

5.2 SAT — Spontaneous Awakening Trial (Despertar Diário)

Contraindicações ao SAT:

- Agitação ativa (RASS ≥ +2)
- Convulsões nas últimas 24h
- Pressão intracraniana elevada (monitorizada > 15 mmHg)
- FiO₂ > 0,7 ou PEEP > 12 cmH₂O
- Procedimentos cirúrgicos programados no dia
- Uso de bloqueador neuromuscular (BNM) ativo
- Isquemia miocárdica ativa ou instabilidade hemodinâmica grave

Execução do SAT:

- 1° Interromper sedação e/ou reduzir infusão de opioides em 50%.
- 2° Aguardar despertar: RASS alvo ≥ -1 em 30 minutos.
- 3° SAT **PASSOU**: paciente desperto, RASS ≥ -1, obedecendo comandos simples → avançar para SBT.
- 4° SAT **FALHOU**: agitação, dessaturação, instabilidade hemodinâmica → retomar sedação na metade da dose prévia.

5.3 SBT — Spontaneous Breathing Trial (Teste de Respiração Espontânea)

Contraindicações ao SBT:

- SAT não realizado ou falhou
- FiO₂ > 0,5 ou PEEP > 8 cmH₂O
- Instabilidade hemodinâmica (norepinefrina > 0,25 mcg/kg/min)
- Frequência respiratória espontânea < 8 ou > 35 ipm
- Distensão abdominal grave interferindo na mecânica respiratória

Modalidades e Execução do SBT:

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

Modalidade	Configuração	Duração	Vantagem
CPAP / PSV mínima	PEEP 5 cmH ₂ O + PS 5-8 cmH ₂ O	30-120 min	Mais fisiológica; preferida
Tubo em T (T-piece)	FiO ₂ = FiO ₂ prévia; sem suporte	30-120 min	Teste mais rigoroso
PSV baixa	PS 7-8 cmH ₂ O; PEEP 5 cmH ₂ O	30-120 min	Alternativa válida

Critérios de SUCESSO do SBT (todos devem estar presentes):

- SpO₂ ≥ 90% (ou PaO₂ ≥ 60 mmHg) em ar ambiente ou FiO₂ prévia
- Frequência respiratória: 8–35 ipm
- Volume corrente espontâneo ≥ 5 ml/kg
- IRRS (Índice de Respiração Rápida e Superficial) = FR/VT ≤ 105
- Frequência cardíaca entre 50–140 bpm (variação < 20% do basal)
- Pressão arterial sistólica: 90–180 mmHg (variação < 20%)
- Nível de consciência adequado: RASS ≥ -1, obedecendo comandos
- Ausência de uso acessório excessivo de musculatura respiratória
- Ausência de diaforese, ansiedade intensa, desconforto evidente

Critérios de FALHA do SBT (qualquer um = interromper):

- SpO₂ < 90% ou queda ≥ 5% do basal
- FR > 35 ipm por mais de 5 minutos
- IRRS > 105
- Rebaixamento do nível de consciência ou agitação intensa
- Instabilidade hemodinâmica (PAS < 90 ou > 180 mmHg)
- Taquicardia ou bradicardia significativa
- Sinais de fadiga: tiragem, respiração paradoxal, diaforese

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

6. EXTUBAÇÃO — CRITÉRIOS, PREPARO E MANEJO PÓS

6.1 Critérios para Extubação (SBT bem-sucedido +):

- SBT de 30-120 min bem-sucedido
- Reflexo de tosse presente e eficaz (capaz de expelir secreções)
- Quantidade e viscosidade de secreções: manejável sem aspirações frequentes
- Capacidade de deglutição preservada (avaliação à beira leito)
- Grau de consciência adequado: obedece 4 dos 4 comandos simples
- Teste do cuff-leak (quando suspeita de edema subglótico): fuga > 110 ml ou > 15%
- Ausência de obstrução de via aérea superior prevista pós-extubação
- Considerar risco de falência pós-extubação: ≥ 2 fatores = alto risco

6.2 Fatores de Alto Risco para Falência Pós-Extubação:

Fator de Risco	Considerar Medida Preventiva
DPOC grave (VEF1 < 50%)	VMNI profilática imediata pós-extubação
ICC descompensada	VMNI ou CPAP pós-extubação
Hipersecreção / tosse fraca	Fisioterapia intensiva; aspiração rigorosa
Estridor pós-extubação	Nebulização adrenalina + dexametasona 10 mg EV
Obeso (IMC > 35)	VMNI preventiva; cabeceira 30-45°
Idoso > 65 anos + comorbidades múltiplas	Observação em UTI ≥ 24h; VMNI se deterioração
Disfagia neurológica	Avaliar fonoaudiologia antes da dieta VO
Extubação > 7 dias de VM	VMNI profilática (reduz re-intubação em ~30%)

6.3 Protocolo de Extubação — Passo a Passo:

Passo	Ação
1°	Confirmar todos os critérios acima + SBT bem-sucedido
2°	Comunicar equipe: medico + fisioterapeuta + enfermagem
3°	Aspirar vias aéreas superiores e ETT antes de desinsuflar cuff
4°	Cabeceira a 45°; monitorização contínua (SpO2, FC, FR, PA)
5°	Desinsuflar cuff completamente + remover ETT com aspiração contínua
6°	Oferecer O2 suplementar: máscara facial 35-50% ou cateter nasal 3-5 L/min
7°	Avaliar estridor (1-15 min pós-extubação): adrenalina nebulizada se presente
8°	Observação mínima de 4 horas em UTI antes de transferência
9°	Iniciar dieta VO após avaliação de disfagia (mínimo 2h pós-extubação)
10°	Registrar data, hora, SBT, condições pré e pós-extubação em prontuário

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

■ FALÊNCIA PÓS-EXTUBAÇÃO ($\leq 48-72h$): Necessidade de re-intubação. Tentar VMNI/OAF como ponte se não houver contraindicação. Re-intubação tardia ($> 6h$ após instalação de falência) associa-se a MAIOR MORTALIDADE. Não protelar re-intubação quando indicada!

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

7. SITUAÇÕES ESPECIAIS E DESMAME DIFÍCIL / PROLONGADO

7.1 Definições:

Categoria	Definição	Prevalência
Desmame simples	SBT bem-sucedido na 1ª tentativa; extubação sem intercorrências	~70% dos casos
Desmame difícil	Até 3 SBTs ou até 7 dias do 1º SBT até extubação	~15% dos casos
Desmame prolongado	Mais de 3 SBTs ou > 7 dias do 1º SBT até extubação	~15% dos casos

7.2 Causas de Falha no Desmame — Investigar Sistematicamente:

Sistema	Causas Comuns	Investigação
Pulmonar/VM	Secreção excessiva, broncoespasmo, atelectasia, derrame	PEx, Rax, BK, culturas, fisioterapia
Cardiovascular	ICC, isquemia, sobrecarga volumétrica, FA	ECG, BNP, ecocardiograma, diurese
Neurológico	Encefalopatia, delirium, AVC, neuropatia/miopatia	UTAM-ICU, EEG, EMG, neurologia
Muscular/Nutricional	Desnutrição, atrofia diafragmática, hipofosfatemia	Albumina, P, Mg, K; fisioterapia
Endócrino/Metab.	Hipotireoidismo, hiperglicemia, distúrbios eletrolíticos	TSH, glicemia, ionograma
Psicológico	Ansiedade, dependência do ventilador, fobia	Suporte psicológico; sedação diurna mínima
Via Aérea	Edema subglótico, estenose traqueal, fraqueza laríngea	Laringoscopia, cuff-leak test

7.3 Estratégias para Desmame Difícil/Prolongado:

- Exercício diafragmático: ultrassom de diafragma (excursão-alvo ≥ 1 cm inspiração profunda)
- Terapia nutricional intensiva: meta calórica ≥ 25 kcal/kg/dia; proteína $\geq 1,5$ g/kg/dia
- Reabilitação motora precoce: sentar na cama → sentar na cadeira → ortostatismo
- Treinamento muscular inspiratório (TMI) com threshold se $PI_{max} < -20$ cmH₂O
- Otimização metabólica: corrigir P, K, Mg, Na, glicemia (70-180 mg/dL)
- Circadiano: SBTs preferencialmente pela manhã; noite = descanso com suporte adequado
- Redução progressiva de PSV: diminuir 2-4 cmH₂O/dia se tolerando
- Considerar traqueostomia se desmame prolongado previsto (> 14 dias)

8. TRAQUEOSTOMIA — QUANDO INDICAR?

Indicação	Prazo Sugerido
VM prolongada prevista (lesão cervical alta, ELA, Guillain-Barré)	Precoce: 7-10 dias
Falha de múltiplos SBTs sem causa reversível identificada	Após 10-14 dias de VM
Necessidade de VM domiciliar ou crônica	Individualizado
Obstrução/lesão grave de VA superior	Imediata (eletiva ou de urgência)
Coma profundo com aspiração recorrente + secreção abundante	7-14 dias
Paciente acordado, cooperativo, que se beneficia de menor sedação	Avaliar individualmente

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

■ *Meta-análises sugerem que traqueostomia precoce (< 7-10 dias) vs tardia não reduz mortalidade, mas pode reduzir dias de sedação e facilitar reabilitação (Tracheostomy Review Collaborative – TracMan trial).*

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

9. DELIRIUM NA UTI — PREVENÇÃO E TRATAMENTO

9.1 Fatores Precipitantes e Medidas Não-Farmacológicas (Protocolo ABCDEF):

Fator	Intervenção Não-Farmacológica
Privação de sono	Reduzir ruído noturno; clusterizar procedimentos; min. luzes 22h-6h
Imobilização	Mobilização precoce; sentar, fisio motora desde D1
Privação sensorial	Oculos e aparelho auditivo no quarto; familiares presentes
Desorientação	Relógio, calendário visíveis; reorientação frequente verbal
Desidratação/Dor	Hidratação adequada; analgesia multimodal otimizada
Drogas psicoativas	Minimizar BZD, anticolinérgicos, corticoides, opioides quando possível

9.2 Tratamento Farmacológico do Delirium:

Fármaco	Dose	Tipo de Delirium	Observações
Haloperidol	2,5-5 mg 8/8h EV ou VO	Hiperativo	1a linha; cuidado QTc; não em Parkinson
Dexmedetomidina	0,2-1,4 mcg/kg/h	Hiper e hipoativo em VM	Reduz delirium; facilita desmame
Quetiapina	25-100 mg 12/12h VO/SNG	Hiperativo	Alternativa; ajuda no sono
Olanzapina	2,5-10 mg VO/SL	Hiperativo	Alternativa ao haloperidol
Rivastigmina	1,5-6 mg 12/12h	Hipoativo	Evidência fraca; avaliar individualmente

■ **IMPORTANT:** Benzodiazepínicos PIORAM o delirium! Evitar ao máximo como sedação de rotina. Se necessário, usar doses mínimas e por período o mais curto possível. MIDAZOLAM aumenta delirium em 2-3x comparado ao propofol.

10. VNI / OAF COMO SUPORTE PÓS-EXTUBAÇÃO

10.1 Oxigenoterapia de Alto Fluxo (OAF / High-Flow):

Fluxo: 40-60 L/min | FiO2 titulada para SpO2 92-96% | Temperatura 37°C.

Indicações pós-extubação: IR hipoxêmica, imunossuprimido, DPOC estável, OAF profilática.

Vantagem: efeito washout de CO2 nasofaríngeo, PEEP intrínseco leve (1-3 cmH2O), conforto superior à máscara.

10.2 VNI (BiPAP) Pós-Extubação:

Indicação	Parâmetros Iniciais	Meta
DPOC com hipercapnia	IPAP 12-16 / EPAP 4-6 cmH2O; FiO2 para SpO2 88-92%	PCO2 < 55 mmHg ou basal
ICC aguda / EAP	CPAP 5-10 cmH2O ou BiPAP 10-15/5 cmH2O	FR < 25; SpO2 > 94%
Pós-extubação profilática	IPAP 10-14 / EPAP 5 cmH2O; 4-8h nas primeiras 24h	Evitar re-intubação
Imunossuprimido	IPAP 12-16 / EPAP 5-6; sessões intermitentes	Evitar IOT (mortalidade alta)

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

■ ■ Falência de VNI: SpO2 não melhora em 1-2h, FR > 35 persistente, deterioração neurológica, incapacidade de manter VNI, piora hemodinâmica. NÃO retardar re-intubação quando indicado!

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

11. CHECKLIST DIÁRIO DE DESMAME — PREENCHER TODA MANHÃ

Paciente: _____ Leito: _____ Data: ____/____/____ Hora: _____

#	Item de Verificação	SIM	NÃO	N/A
1	Causa da VM identificada e em resolução?	☐	☐	☐
2	SpO ₂ ≥ 92% com FiO ₂ ≤ 0,4 e PEEP ≤ 8?	☐	☐	☐
3	Hemodinamicamente estável (sem ou baixo vaso)?	☐	☐	☐
4	RASS ≥ -2 e GCS ≥ 10?	☐	☐	☐
5	Dor controlada (BPS ≤ 5 / NRS ≤ 3)?	☐	☐	☐
6	Eletrólitos corrigidos (K, P, Mg)?	☐	☐	☐
7	Temperatura < 38,5°C?	☐	☐	☐
8	Sem contraindicação ao SAT?	☐	☐	☐
9	SAT realizado e resultado: PASSOU / FALHOU?	☐	☐	☐
10	Sem contraindicação ao SBT?	☐	☐	☐
11	SBT realizado? Duração: _____ min. Resultado: PASSOU / FALHOU?	☐	☐	☐
12	IRRS calculado: _____ (alvo ≤ 105)?	☐	☐	☐
13	Tosse eficaz avaliada?	☐	☐	☐
14	Risco de falência pós-extubação avaliado?	☐	☐	☐
15	Paciente e família orientados?	☐	☐	☐
16	CAM-ICU realizado? Resultado: POS / NEG?	☐	☐	☐
17	Fisioterapia motora realizada hoje?	☐	☐	☐
18	Nutrição enteral/parenteral otimizada?	☐	☐	☐

Médico responsável: _____ CRM: _____

Fisioterapeuta: _____ CREFITO: _____

Enfermeiro: _____ COREN: _____

12. REFERÊNCIAS E GRAU DE EVIDÊNCIA

1. Devlin JW et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption (PADIS) in Adult Patients in the ICU. *Crit Care Med* 2018;46(9):e825-e873.
2. Girard TD, Ely EW. Discontinuing Ventilatory Support: Weaning Protocols. *Crit Care Med* 2008;36(4 Suppl):S215-S224.
3. Ely EW et al. Effect on the Duration of Mechanical Ventilation of Identifying Patients Capable of Breathing Spontaneously (SAT/SBT Protocol). *N Engl J Med* 1996;335:1864-1869.
4. Boles JM et al. Weaning from Mechanical Ventilation. *Eur Respir J* 2007;29:1033-1056.
5. Schmidt GA et al. Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults: An Official ATS/ACCP Clinical Practice Guideline. *Chest* 2017;151:166-180.
6. Papazian L et al. Neuromuscular Blockers in Early Acute Respiratory Distress Syndrome. *N Engl J Med* 2010;363:1107-1116.

PROTOCOLO DE DESMAME DE VM & SEDOANALGESIA

UTI Adulto | Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE

7. Marra A et al. *The ABCDEF Bundle in Critical Care*. *Crit Care Clin* 2017;33:225-243.

8. AMIB. *Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica – 2013*. *J Bras Pneumol* 2014;40(4):361-386.